

B

非悪性腫瘍
except tumors

到達目標

- 非がん性呼吸器疾患の呼吸困難のマネジメントが理解できる
- 非がん性呼吸器疾患の精神症状のマネジメントが理解できる
- 非がん性呼吸器疾患患者のアドバンス・ケア・プランニングが理解できる

1 背景

慢性閉塞性肺疾患（COPD）の終末期には、呼吸困難、咳嗽、喀痰などの呼吸器症状に加え、倦怠感、るいそう、抑うつ、不安、不眠など多彩な症状を呈する。呼吸困難については、死亡前3～6ヵ月のCOPD患者の約3分の2の症例で認められ、診断時の特発性肺線維症患者の約9割で認められる。非がん性呼吸器疾患の精神症状については、抑うつ、不安、パニック症、不眠の頻度が高い。

2 症状マネジメント

a 呼吸困難のマネジメント

まずは、気管支拡張薬、抗線維化薬、呼吸リハビリテーションといった各疾患の標準治療をしっかりと行う。安静時低酸素血症を認めない患者においては、労作時の酸素吸入が労作時の呼吸困難を改善させることが報告されている¹⁾。労作時呼吸困難を有する非がん性呼吸器疾患患者の呼吸困難に対するモルヒネの有効性を検討したメタ解析ではプラセボとの間に有意差を認めなかった²⁾。したがって、モルヒネは、原疾患への治療や、他の対症療法を行ってもコントロールが不十分な重症の呼吸困難（安静時呼吸困難、死亡直前期の呼吸困難など）に対する治療選択肢と位置づけられている。また、重症COPD患者において30mg/日以上の高用量のモルヒネ使用は、死亡率、入院率の上昇と関連していた³⁾。投与開始後、効果がなければ中止し、効果がないのに漫然と投与することは避ける。COPDの呼吸困難に対する非薬物治療として、神経電気学的刺激や顔面への送風の有効性が報告されてい

る。

b 精神症状のマネジメント

重症COPD患者において、ベンゾジアゼピン系薬はCOPDの増悪、救急室受診の増加、死亡率の上昇との関連が報告されている^{3,4)}。特にII型呼吸不全を有するCOPD患者においてはCO₂ナルコーシスをきたす可能性があり、注意が必要である。抑うつに対してはうつ病の診断基準を満たす場合にはSSRIなどの抗うつ薬を用いる。COPD患者において、呼吸リハビリテーションが不安、抑うつを改善し⁵⁾、認知行動療法が不安、抑うつ、パニック症/パニック発作を改善することが示されている⁶⁾。不眠に対しては睡眠衛生教育をしっかりと行った上で、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬といった呼吸に対する影響が少ない薬剤を選択する。また、ステロイドによる不眠、うつ病を疑う場合には減量、中止ができないか検討する。

3 アドバンス・ケア・プランニング

非がん性呼吸器疾患患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの適切なタイミングの例として、頻回の急性期治療や入院を繰り返すとき、在宅酸素療法や非侵襲的人工呼吸器が必要になったとき、訪問診療に移行したときなどが挙げられる。その時々で病状および病状認識が変化することを考慮し、繰り返し、可能であれば早期に今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合うことが推奨される。

文 献

- 1) Hasegawa T, et al : Respir Investig 61 : 418, 2023
- 2) Smallwood NE, et al : Eur Respir Rev 33 : 230265, 2024
- 3) Ekstrom MP, et al : BMJ 348 : 445, 2014
- 4) Vozoris NT, et al : Eur Respir J 44 : 332, 2014
- 5) Gordon CS, et al : Chest 156 : 80, 2019
- 6) Ma RC, et al : Complement Ther Clin Pract 38 : 101071, 2020